

Una persona autistica nella vostra struttura residenziale / ad alto supporto

Per assistenti residenziali, assistenti personali e personale di comunità — sostenere una persona autistica in assistenza / cura ad alto supporto (qualsiasi età).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di una persona si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Per una persona autistica ad alto supporto, gli ambienti di cura sono spesso i **più difficili in assoluto**: ostili sul piano sensoriale, dirompenti per la routine, pieni di contatto e richieste imprevedibili. Molti comunicano senza parlare e potrebbero non registrare o segnalare dolore se non quando è grave. Il cambio singolo più utile è leggere **ogni comportamento come comunicazione di un bisogno non soddisfatto** — dolore, paura, sovraccarico o una routine perduta — e proteggere prevedibilità, oggetti e agency. Dignità e consenso dipendono dal lavorare *con* la persona, non dal dare per scontata l'incapacità.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
„Comportamento problematico”, autolesionismo, rifiuto	Nella stragrande maggioranza comunicazione di un bisogno non soddisfatto — dolore, paura, sovraccarico, routine perduta
Meltdown o shutdown durante le cure	Risposta involontaria del sistema nervoso al sovraccarico — <i>non</i> aggressione o non-collaborazione
Non segnala dolore; collasso improvviso / presentazione tardiva	Differenze di interocezione — i segnali interni possono non registrarsi se non quando gravi
Ritiro quando cambiano oggetti, ordine o personale	Routine e oggetti sono ancore di identità e sicurezza
Nessuna parola affidabile; si affida a CAA o a un accompagnatore	Comunicazione atipica ≠ mancanza di capacità o di comprensione

Provate questo

- **Costruite le cure attorno alla prevedibilità**: personale costante, stessa sequenza, agende visive, preavviso di ogni cambio.
- **Riducete il carico sensoriale** — stanza quiete, luce soffusa, meno bip e odori forti; conservate gli oggetti, gli interessi e le routine della persona.
- **Indagate prima il dolore e le cause fisiche** per ogni nuovo malessere o cambio di comportamento — stitichezza, dolore dentale, infezioni, attrezzature mal calibrate sono colpevoli comuni e nascosti.
- **Usate il decision-making supportato**: spiegate in forma accessibile e letterale; concedete tempo di elaborazione; consultate l'accompagnatore di fiducia ed eventuale profilo comunicativo/anticipato.
- **Avere un piano calmo e scritto per meltdown/shutdown**: riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, date tempo e spazio — non contenete e non punite.

- **Documentate e condividete un profilo individualizzato sensoriale, comunicativo e di reasonable adjustments.**

Da evitare

- Etichettare il malessere come „comportamentale” prima di aver escluso dolore e sovraccarico.
- Usare la contenzione o la sedazione come prima risposta a meltdown/shutdown.
- Rimuovere routine, oggetti o interessi „per il loro bene”, o assumere l’incapacità dalla comunicazione atipica.

Quando chiedere altro supporto

Trattate il **malessere nuovo o crescente** come una red flag medica finché dolore, infezione, stitichezza, problemi dentali e cause sensoriali/ambientali non sono esclusi. Cercate il **burnout autistico** sotto carico cronico. Coinvolgete i **team specialistici autismo / disabilità intellettiva** e logopedia (CAA). Tenete pronto un „passaporto ospedaliero/sanitario” per ogni ricovero.

Nota di genere

Le donne ad alto supporto sono particolarmente sotto-individuate e poco seguite; il loro malessere è ancora più spesso frainteso. Applicate lo stesso rigore nell’escludere dolore e sovraccarico a prescindere dalla presentazione o dal metodo di comunicazione.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 5, RSA e ospedali), la guida **Pratici e sanità lungo l’arco di vita** (Parti 3.5 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l’identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interocezione/dolore); Autism Society (2025, meltdown/shutdown); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.